

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	INDUKSI PERSALINAN		
	No. Dokumen 571.27/I-SPO/MTR/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 18 Juli 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Induksi persalinan yaitu tindakan baik secara operatif maupun medisinal untuk merangsang timbulnya kontraksi uterus sehingga terjadi persalinan. Akselerasi persalinan yaitu meningkatkan frekuensi, lam dan kekuatan kontraksi uterus dalam persalinan.		
Tujuan	Mencapai kontraksi uterus yang adekuat		
Kebijakan	1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 571.2/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman PONEK 24 jam 2. Dilakukan oleh Dokter dan Bidan		
Prosedur	1) Persiapan a. Persiapan alat 1. Partus set (1 set) 2. Antiseptik 3. Infus set 4. Oksitosin/prostaglandin/mesoprostol 5. Doek steril (3 buah) 6. Dekatkan alat b. Persiapan Ibu (pasien) 1. Lakukan komunikasi terapeutik kepada ibu 2. Jelaskan tindakan yang akan dilakukan beserta tujuannya 3. Atur posisi sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan 4. Kosongkan kandung kemih, rektum serta membersihkan daerah perineum dengan antiseptik c. Lingkungan aman dan nyaman Pasang sketsel / tutup korden 2.Pelaksanaan 2.1.Aminiotomi 1. Cuci tangan 6 langkah 2. Kaji ulang indikasi 3. Periksa denyut jantung janin (DJJ) 4. Lakukan pemeriksaan serviks dan catat konsistensi, posisi, penipisan, dan pembukaannya dengan		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	INDUKSI PERSALINAN		
	No. Dokumen 571.27/I-SPO/MTR/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 2 / 3
	menggunakan sarung tangan DTT - Masukkan setengah kocher yang dipegang tangan kiri dan dengan bimbingan jari tengah kanan hingga menyentuh selaput ketuban. - Gerakkan kedua ujung jari tangan dalam untuk memorehkan gigi kocher hingga merobek selaput ketuban. - Cairan ketuban mengalir perlahan. Catat warnanya, kejernihan, pewarnaan mekoneum dan jumlahnya. Jika ada pewarnaan mekoneum tandanya suspek gawat janin. - Pertahankan jari tangan dalam vagina agar air ketuban mengalir perlahan dan yakin tidak teraba bagian kecil janin atau tali pusat yang menumbung. - Setelah amniotomi, periksa DJJ pada saat kontraksi dan sesudah kontraksi uterus. Apabila ada kelainan DJJ (kurang dari 100 atau lebih dari 160/menit) tandanya suspek gawat janin. - Jika kelahiran diperkirakan tidak terjadi dalam 12 jam, berikan antibiotika pencegahan dengan penisilin G (2 juta IU) iv atau Ampicillin (2 gram) iv. Ulangi tiap 6 jam sampai kelahiran. Jika tidak ada tanda-tanda infeksi pada pasien sesudah melahirkan pemberian antibiotika dihentikan. - Jika proses persalinan yang baik tidak terjadi dalam 1 jam setelah aminiometri, mulailah infus dengan oksitosin. - Pada persalinan dengan masalah misalnya sepsis atau eklampsia, infus oksitosin dilakukan bersamaan dengan amniotomi.		
Prosedur	2. 2.Cara Oksitosin - Kaji ulang indikasi - Baringkan pasien miring kiri - Oksitosin digunakan secara hati-hati karena gawat janin dapat terjadi diakhiri hiperstimulasi. Walaupun jarang, ruptura uteri dapat pula terjadi terutama pada multi para. - Dosis efektif oksitosin bervariasi, infus oksitosin dalam Dextrose atau Garam Fisiologik dengan tetesan dinaikkan secara gradual sampai kontraksi uterus adekuat. - Pantau denyut nadi, tekanan darah dan kontraksi uterus pasien, juga DJJ - Catat semua pengamatan pada partograf tiap 30 menit, kecepatan infus, frekuensi dan lamanya kontraksi uterus, DJJ didengarkan tiap 30 menit atau langsung setelah kontraksi uterus. Apabila terjadi gawat janin segera hentikan infus. - Infus oksitosin 5 unit dalam 500 cc dextrosa 55 / Garam Fisiologis mulai 8 tetes/menit. Setiap 15 menit dinaikkan		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	INDUKSI PERSALINAN		
	No. Dokumen 571.27/I-SPO/MTR/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 3 / 3
	kecepatannya sebanyak 4 tetes sampai tercapai kontraksi uterus yang adekuat (3 kali kontraksi dalam 10 menit dengan lama 40-50 detik) dengan tetesan maksimal 40 tetes/menit. 8. Jika terhadap hiperstimulasi (lama kontraksi uterus lebih dari 4 kali dalam 10 menit atau lama kontraksi uterus lebih dari 60 detik), hentikan infus dan kurangi hiperstimulasi dengan: - Terbutolin 250 mcg pelan-pelan selama 5 menit atau - Salbutamol 5 mg dalam 500 cc cairan garam fisiologik atau Ringer Laktat 10 tetes/menit. 9. Jika masih tidak tercapai kontraksi uterus yang adekuat dengan dosis oksitosin maksimal maka induksi dianggap gagal dilakukan Seksio Sesarea.		
	2) Dokumentasi • Respon pasien pada saat di lakukan tindakan tersebut • Nilai kondisi pasien (vital sign, keluhan subyektif, his, BJA, kemajuan persalinan)		
Unit Terkait	1. IGD 2. Ruang Bersalin		